ELLENŐRZŐ LISTA HÁZIORVOSOKNAK

SGLT-2-gátló terápia (empa- vagy dapagliflozin) alkalmazása T2DM-ben[1,2]

SGLT-2-gátló kezelés T2DM-ben javasolt:

- ☐ A T2DM korszerű kezelésére mint a betegség lefolyását módosító terápia
- ☐ Akiknél szeretnénk kivédeni a lehetséges kardiovaszkuláris és renális szövődmények kialakulásának kockázatát
- ☐ Amennyiben már kialakultak ezek a szövődmények, a további progresszió elkerülésének a céljából

SGLT-2-gátló kezelés nem javasolt:

- ☐ 1-es típusú cukorbetegség esetén
- ☐ A felnőttkorban kezdődő, ún. hibrid vagy régi nevén LADA típusú cukorbetegség esetén
- ☐ Az inzulinra szoruló 2-es típusú cukorbetegek esetén, ha nincs endogén inzulinszekréciójuk, azaz a C-peptid-szintjük alacsony

SGLT-2-gátló terápia indítható támogatottan: (EÜ70 1/a)

Dokumentált T2DM-ben, amennyiben életmód-terápia és metforminkezelés legalább 3 hónapig tartó alkalmazása ellenére a megfelelő szénhidrátanyagcsere-helyzet (HbA1c > 7%) nem volt elérhető

- ☐ Metforminterápián lévő beteg legalább 3 hónapig és
- ☐ HbA1c > 7%

VAGY

Dokumentált T2DM-ben, amennyiben a betegnek az alábbi igazolt társult betegsége is van (HbA1c-értéktől függetlenül):

- ☐ Csökkent ejekciós frakciójú szívelégtelenség*

vagy

- ☐ Csökkent eGFR-rel járó krónikus vesebetegség#

Mit szükséges ellenőrizni az SGLT-2-gátló terápia alkalmazása során?

Vesefunkció ellenőrzése:

- ☐ Jelenlegi vesefunkció eGFR ≥ 20 ml/perc/1,73 m^2 → empagliflozin 10 mg napi dózis indítható
- ☐ Jelenlegi vesefunkció eGFR ≥ 25 ml/perc/1,73 m^2 → dapagliflozin 10 mg vagy empagliflozin 10 mg napi dózis indítható
- ☐ Az elkezdett terápia dialízisig folytatható§

Ketoacidózis kockázatának kizárása:

- ☐ A beteg nem megy keresztül hosszan tartó éhezésen, erre vonatkozó diétát sem tart

Volumenstátusz ellenőrzése:

- ☐ Nincs olyan állapotban a beteg, amely folyadékvesztéshez vagy kiszáradáshoz vezet

Genitális infekciókra való hajlam mérlegelése

- ☐ A személyes higiénia betartására alkalmas a beteg

Egyéb:

- ☐ Akut súlyos betegség, lázas, fertőzéses állapot nem áll fenn
- ☐ A beteg nem esik át nagyobb sebészeti műtéten az elkövetkező 72 órában

Mire érdemes felhívni a beteg figyelmét az SGLT-2-gátló terápia alkalmazása során?

- ☐ Fertőzések korai jeleinek felismerése, a személyes higiénia betartása
- ☐ Hányás, hasmenés vagy láz esetén a gyógyszer átmeneti felfüggesztése javasolt, és mielőbbi orvosi kontroll szükséges – a terápia a legtöbb esetben újraindítható a tünetek elmúltával
- ☐ Fontos a megfelelő folyadékbevitel
- ☐ Ketoacidózis tüneteinek ismertetése: hányinger, hányás, hasi fájdalom, légszomj, zavartság

Mikor és milyen ok miatt kell kontrollra visszajönnie a betegnek?

- ☐ Vesefunkció-ellenőrzés, folyadék- és elektrolitstátusz miatt 1-3 hónap múlva, ezután legalább évente
- ☐ HbA1c-érték-mérésre 3-6 havonta

Mikor kell diabetológusnak referálni a beteget a kezelés felülbírálására?

- ☐ Tartós vesefunkció-rosszabbodás esetén (eGFR > 30%-os csökkenése az indítás utáni 1-3 hónapban)
- ☐ Ismételt genitális fertőzések esetén
- ☐ Gyakori hypoglikémiás epizódok esetén
- ☐ Nem kielégítő HbA1c-kontroll esetén: több hónapos SGLT-2-gátló kezelés után HbA1c > 7%
- ☐ Ketoacidózis gyanúja esetén, sürgős diabetológiai vagy kórházi ellátás céljából

---

* A krónikus szívelégtelenség három típusa: csökkent (LVEF ≤40%), enyhén csökkent (LVEF 41–49%) és megtartott (LVEF ≥50%) ejekciós frakciójú szívelégtelenség[3]

\# Az eGFR normál tartománya: ≥ 90 ml/perc/1,73m^2

§ Ha a jelenlegi vesefunkció eGFR ≥ 60 ml/perc/1,73 m^2 és fokozott glikémiás kontroll szükséges, az empagliflozin napi dózisa 25 mg-ra emelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK

A készítmények alkalmazása során minden esetben az érvényes alkalmazási előírás az irányadó. Jelen dokumentum terjedelmi korlátai miatt nem ad teljes körű tájékoztatást az alkalmazási előiratokban foglaltakról, és nem tekinthető azok helyettesítőjének.

Hivatkozások jegyzéke:

1. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban; Diabetologia Hungarica; 2023, XXXI. évfolyam 5. szám Diabetologia Hungarica 2023/5.pdf

2. Egészségügyi szakmai irányelv – A felnőttkori idült vesebetegség diagnózisa és kezelése; Hypertonia és Nephrologia; 2025;29(Suppl. 1):S1–S48. http://nephrologia.hu/upload/nephrologia/document/h_and_n_suppl_ckd_iranyelv_2025.pdf?web_id=

3. Egészségügyi Közlöny; 2026; LXXVI. ÉVFOLYAM 2. szám https://www.neak.gov.hu/pfile/file?path=/letoltheto/EOSZEF_letoltheto_doku/002271-2026-a-kronikus-szivelegtelensegrol&inline=true

4. Indikációhoz kötött készítmények EÜ PONT https://neak.gov.hu/letoltheto/ATFO_dok/gyogyszer/ind

Empagliflozin alkalmazási előírás: INN-empagliflozin

Dapagliflozin alkalmazási előírás: INN-dapagliflozin

Mellékhatások bejelentése:

A feltételezett mellékhatásokat kérjük jelenteni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) részére a https://ogyei.gov.hu oldalon elérhető online felületen.

Rövidítésjegyzék:

T2DM = 2-es típusú diabetes mellitus
SGLT-2-gátló kezelés = nátrium-glükóz kotranszporter-2-gátló-kezelés
LADA = felnőttkorban manifesztálódó autoimmun diabetes
HbA1c = glikált hemoglobin
eGFR = becsült glomerulus filtrációs ráta
LVEF = bal kamrai ejekciós frakció
HF = krónikus szívelégtelenség
CKD = krónikus vesebetegség

A dokumentum elkészítésében és orvosszakmai lektorálásban közreműködött:

Prof. Dr. Lengyel Csaba
A Magyar Diabetes Társaság Elnöke

Dr. Kárpáti István
A Magyar Nephrologiai Társaság Elnöke

Prof. Dr. Wittmann István
A Szakmai Kollégium Nephrologiai és Dialízis Tagozatának Elnöke

Dr. Ladányi Erzsébet
Nefrológia és Dialízis Országos Szakfelügyelő Főorvos